



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : زهرة كامل احمد حجازى
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : شبرا
رقم البطاقة : 25804050101629 رقم التليفون : 01026682230
العنوان : حدائق القبة
العمر (تاريخ الميلاد) : 05-04-1958 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: زهرة كامل احمد حجازي National ID: 25804050101629	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢٥/١٠
٢٥١١٠٠٣٠١٠٦٢٩
حائضه حتى يكتمل رويس بطر
البيضاء مسارية حتى ٢٠٣٢/١٠/٢٩
البيضاء مسارية حتى ٢٠٣٢/١٠/٢٩





MDT FORM

19/10/2025 G

Name	زهرة كامل أيز	MRN	14.0/C.90
Age	67	ID	508.4.0.1.1799
Menopausal status	post	Phone	01026682250 01020856899
NRS SCORE		Marital status	married
BMI		Family history	-ve
CO morbidity	HTN, DM	REASON OF MDT	post operative

Clinical Data

BX: IDC

ER: 8/8 PR: 8/8 HER 2: 3 Ki67: 25

Sonomammography:

Mets Workup:

R

L



TNM

post operative → T₂N₁

Recommendations: patient underwent left breast conservative surgery & left SLNB with free margins and pathologic complete response. post operative → ypTo ypMo
Good healing for Adttt

MDT OUTCOME & PLAN

for Adttt Herceptin sc. ypoh Ag
+ PACE, Aradex

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Patient Name	: الأستاذة / زهره كامل احمد حجازي	Request No.	: 13000693
Patient No.	: 25804050101629	Request Date	: 29/04/2025
Path No.	: SR-639/25	Verification Date	: 07/05/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 67 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.
Nature of Specimen: Slide Revision.

Gross Examination:

- Five slides labelled by (703857) were received.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade II (3+2+1).
- * DOIS: Not detected.
- * Angioinvasion: Not detected.
- * Perineural invasion: Not detected.
- * Microcalcifications: Not detected.
- * IPT:
 - ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
 - PR: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
 - Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).
 - Ki67: 25% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast mass, Slide revision:
Invasive duct carcinoma, grade II.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 25% of tumor cells

Verified by :

Dr.Toka Medhat



Patient Name	: الأستاذ / زهره كامل احمد حجازي	Request No.	: 13003219
Patient No.	: 25804050101629	Request Date	: 01/10/2025
Path No.	: 2993/25	Verification Date	: 11/10/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوسف روسي - نفقة الدولة
Age	: 67 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data : Left breast cancer post NACT

Nature of the specimen : Left breast conservartive surgery & Left sentinel lymph node biopsy .

Gross Examination:

Three specimens were received :

1- Left BCS specimen measured 11 x8x3 cm , covering skin ellipse measured 11x3 cm .

Cut section revealed 2 wired areas :

-Wire guided area was well defined greyish white firm tumour bed site measured 3.5x2.5x1.5 cm

3 - SLN biopsy : A fibrofatty tissue measured 4x3 cm enclosing 6 SLNs

• Frozen section: Free margins .& Free SLNs (0/6)

Block designation :

1.medial

2.lateral

3.superior

5.inferior

6.SLNDs

7:10 TBS .

GROSSING BY : Dr.Heba El-Shafeey

Microscopic examination:

• Histological type: No residual tumor

• Angioinvasion: No

• Lymph node involvement: Free SLNs (0/6)

• Resection Margins: Free margins

• Histologic response to therapy: Pathologic complete response

• Additional pathologic findings: N/A

Verified by :

Dr.Heba Hasan



Patient Name : الأستاذة / زهره كامل احمد حجازي
Patient No. : 25804050101629
Path No. : SR-639/25
Sex : Female
Age : 67 Y
Referring Doc :

Request No. : 13000693
Request Date : 29/04/2025
Verification Date : 07/05/2025
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Signature
Dr. Walaa Ghonaim
Dr. Yasmine Essam

Verified by :
Dr.Toka Medhat

Printing Date : 14/05/2025 12:29:32

Page 2 of 2

Printing By : hermal



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

د. أحمد كمال الدري
د. محمد أبو الهدى درويش
د. عمر حسين عمر
د. وحيد حسين طنطاوى
د. ياسر عبد العظيم عباس
د. أحمد محمد منيب
أساتذة الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

MRS: ZAHRA KAMEL AHMED
DEAR SIR

PATIENT ID: 1282919
STUDY DATE: 10/05/2025

F18- FDG PET/CT EXAMINATION

History:-

67 years old female patient, with of left breast cancer pathologically proven to be infiltrative ductal carcinoma, referred for PET/CT examination.

Procedure:-

- 8.4 mCi 18F-FDG was administered to the patient and imaged after appropriate time.
- The blood glucose level was 109 mg/dl.
- A low dose non-contrast CT for attenuation correction and anatomic localization followed by PET images from the skull vault to the mid thigh were obtained.
- A diagnostic 128 MDCT post contrast examination was taken after I.V. non-ionic contrast administration of the same regions. Images of CT and corresponding functional PET images are taken in axial, coronal and sagittal planes.

PET/CT FINDINGS:-

A] Head and Neck:-

- Few small insignificantly avid reactionary looking bilateral upper deep cervical and submandibular lymph nodes are seen with preserved ovoid outline measuring up to 5 mm in short axis.
- The brain exhibited normal FDG biodistribution.
- Physiological FDG uptake is seen in the oropharynx, salivary glands and larynx.
- The thyroid gland is mildly enlarged showing mild diffuse increase FDG uptake achieving up to 5.9 SUVmax, with mild retrosternal extension detected, associated small insignificantly avid thyroid isthmus nodule measuring 4.5 mm, for US correlation.



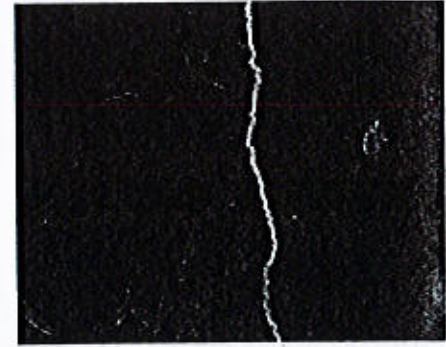
أ.د. أحمد كمال الدري
أ.د. محمد أبو الهدى درويش
أ.د. عمر حسين عمر
أ.د. وحيد حسين طنطاوي
أ.د. ياسر عبد العظيم عباس
أ.د. أحمد محمد منيب
أساتذة الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

MRS: ZAHRA KAMEL AHMED
DEAR SIR

PATIENT ID: 1282919
STUDY DATE: 10/05/2025

B] Chest:-

- The left breast shows an irregular lobulated enhancing hypermetabolic neoplastic mass implicating its lower outer quadrant, measuring 29.5x29x33.5 mm and achieving up to 23.02 SUVmax, with related few fibrotic bands.
- **Enlarged rounded hypermetabolic left axillary lymph node** is seen, measuring 20x16.5 mm and archiving up to 25.32 SUVmax.
- No suspicious hypermetabolic right breast lesions detected.
- No hypermetabolic mediastinal, hilar or right lymphadenopathy.
- No suspicious hypermetabolic pulmonary nodules detected
- Few bilateral subpleural fibrotic lung bands are seen with faint pulmonary ground glassing likely inflammatory.
- No pleural effusion.
- Small axial hiatus hernia.



C] Abdomen & Pelvis:-

- There is normal distribution of the radiotracer within the gastrointestinal and genitourinary systems without focal areas of abnormal metabolism.
- Physiological uptake in the liver, adrenal glands, spleen and pancreas.
- Physiological excretion of FDG in the kidneys.
- No ascites or hypermetabolic lymphadenopathy noted.
- Clear cholecystectomy operative bed.
- Anterior abdominal supraumbilical surgical mesh/clips seen related to the anterior abdominal wall muscles, likely of previous hernial repair.
- Small midline anterior abdominal wall paraumbilical non complicated fat containing hernia is noted.



Patient Name: Zahra Kamel Ahmed Hegazy	Date: 14/05/2025
Exam: ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age: 67 Year(s)
Medical ID: 1405/2025	Pat. ID: 99546

Bilateral breast ultrasound

Indication:

left breast palpable lump.

Technique

- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Left breast:
- left breast irregular spiculated hypoechoic mass lesion, with subtle vascularity detected within on color Doppler, seen at 2 o'clock position 2cm from the nipple, 0.1 cm from the overlying skin, measuring 3.4x2.6 cm, consistent to the palpable lump.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the right breast.
- Two Pathological left axillary lymph nodes are seen with muffled hila, largest measuring 1.3x1.9cm, with cortical thickness reaching 10 mm
- Free left supra and infraclavicular regions
- Right breast:
- No suspicious right breast mass lesions
- Nonspecific right axillary LN.
- Free right supra and infraclavicular regions.

Opinion:

- Left breast UOQ malignant looking mass lesion (BIRADS 5) for histopathological correlation.
- Pathological left axillary LNs.
- Benign findings right breast (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr Basma Mohamed

14/05/2025 2:43 PM.

ا.د. أحمد كمال الدري
ا.د. محمد أبو الهدى درويش
ا.د. عمر حسين عمر
ا.د. وحيد حسين طنطاوى
ا.د. ياسر عبد العظيم عباس
ا.د. أحمد محمد منيب
أساتذة الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

MRS: ZAHRA KAMEL AHMED
DEAR SIR

PATIENT ID: 1282919
STUDY DATE: 10/05/2025

- Multiple small non complicated sigmoid and descending colonic diverticulosis are seen with clear surrounding fat planes and no paracolic localized collection detected.

D] Musculoskeletal:-

- No metabolically active osseous lesions detected.
- Diffuse hyperactive bone marrow, likely attributed to element of cytopenia, for lab correlation.

CONCLUSION:-

- Left LOQ hypermetabolic neoplastic breast mass, pathologically proven to be infiltrating ductal carcinoma.
- Associated enlarged hypermetabolic regional left axillary metastatic lymph node.
- No otherwise suspicious hypermetabolic lesions detected elsewhere in the body.

MUCH OBLIGED

PROF. DR. YASSER IBRAHIM
PROF. DR. OMAR HUSSEIN

A. PROF. DR. BASANT RAIEF